DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: BERNARDO PERLAZA PERLAZA **Identificación** CC 10388054
Edad: 48 AÑOS **Empresa:** POLICIA NACIONAL AMBULATORIO 2025-2
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 10/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	W21	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: K297 GASTRITIS NO ESPECIFICADA

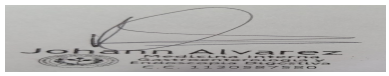
Dx Postoperatorio: K297 GASTRITIS NO ESPECIFICADA

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 10/11/26 **Fecha Final** 10/11/26
Hora Inicio 12:40:00 **Hora Final** 12:55:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE REALIZA PROCEDIMIENTO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POR SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TRATANTE TENIENDO EN CUENTA VENTILACIÓN MECÁNICA Y DIFICULTAD PARA DESPLAZAMIENTO.
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: Sindrome anémico
ESOFAGO: Normal hasta tercio distal. Cardias franqueable.
ESTOMAGO: Explorado hasta píloro incluyendo retrovisión para pequeña curva y fondo gástrico normales. Fondo y cuerpo gástrico proximal con abundante residuo alimentario que limita sensibilidad. Resto de mucosa corporoantral con múltiples erosiones de predominio prepilórico sin evidencia de úlceras, sangrado activo o reciente. Motilidad antral normal. Píloro franqueable.
DUODENO: Normal hasta segunda porción.
BIOPSIAS: No se toma por evento agudo.
***CONCLUSION:
1. GASTRITIS CORPOROANTRAL EROSIVA SEVERA

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***